==========

PENYAKIT : INFLUENZA (FLU)

==========

Pengertian

Infeksi saluran pernapasan akut yang menular.

Penyebab

Virus Influenza (A, B, C).

Gejala

Demam, batuk kering, nyeri otot, hidung tersumbat, sakit kepala.

Diagnosis

Belum tersedia.

Pengobatan

Istirahat, hidrasi, obat penurun panas (parasetamol).

Pencegahan

Vaksinasi tahunan, cuci tangan, pakai masker.

Kapan harus ke dokter

Sesak napas, demam tidak turun lebih dari 3 hari.

Faktor risiko

Musim hujan, daya tahan tubuh menurun, kontak dengan penderita.

Referensi medis

WHO, Kemenkes RI

==========

PENYAKIT : COMMON COLD

==========

Pengertian

Infeksi virus ringan pada hidung dan tenggorokan.

Penyebab

Rhinovirus, Coronavirus.

Gejala

Bersin, hidung meler, sakit tenggorokan, batuk ringan.

Diagnosis

Belum tersedia.

Pengobatan

Istirahat, minum air hangat, dekongestan.

Pencegahan

Jaga imunitas, hindari menyentuh wajah dengan tangan kotor.

Kapan harus ke dokter

Batuk lebih dari 2 minggu, muncul nyeri dada.

Faktor risiko

Kelelahan, stres, berada di ruang tertutup dengan penderita.

Referensi medis

CDC, Mayo Clinic

==========

PENYAKIT : DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)

==========

Pengertian

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus dan ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Penyakit ini tergolong berbahaya karena dapat menyebabkan kebocoran pada pembuluh darah mikro. Kondisi tersebut mengakibatkan jumlah trombosit (keping darah yang berfungsi membekukan darah) menurun secara drastis, sehingga tubuh berisiko tinggi mengalami perdarahan hebat yang dapat mengancam nyawa jika tidak ditangani dengan cepat.

Penyebab

Penyebab utama dari penyakit ini adalah Virus Dengue. Virus ini tidak dapat menular secara langsung dari manusia ke manusia. Penularannya membutuhkan bantuan perantara (vektor), yaitu nyamuk betina dari spesies Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nyamuk ini biasanya aktif menggigit pada pagi dan sore hari. Ketika nyamuk menggigit orang yang sudah terinfeksi, virus akan masuk ke dalam tubuh nyamuk dan siap ditularkan ke orang sehat melalui gigitan berikutnya.

Gejala

Gejala DBD umumnya muncul dalam waktu 4 hingga 10 hari setelah seseorang digigit oleh nyamuk pembawa virus. Beberapa gejala khas yang perlu diwaspadai meliputi:

- **Demam Pelana Kuda**: Demam tinggi mendadak hingga mencapai 40°C yang berlangsung selama 2 hingga 7 hari. Demam ini berbentuk seperti pelana kuda karena sempat turun pada hari ke-3 atau ke-4 (fase kritis yang sering mengecoh karena pasien dikira sudah sembuh), lalu melonjak naik kembali.
- **Nyeri Sendi dan Otot**: Rasa sakit yang hebat pada persendian, otot-otot tubuh, serta sensasi nyeri di bagian belakang bola mata.
- **Bintik Merah di Kulit**: Munculnya ruam atau bintik-bintik kemerahan (petekie) yang tidak pudar atau hilang saat kulit ditekan.
- **Gangguan Pencernaan**: Rasa mual yang parah, muntah-muntah, dan hilangnya nafsu makan secara total sehingga tubuh menjadi sangat lemas.

Diagnosis

Dokter menegakkan diagnosis DBD melalui beberapa langkah medis berikut:

- **Pemeriksaan Fisik**: Mengidentifikasi gejala klinis yang tampak dan melakukan uji bendungan (Tes Rumple Leede) menggunakan tensimeter untuk memicu munculnya bintik merah pada lengan.

==========

- **Tes Antigen NS1**: Tes darah cepat untuk mendeteksi keberadaan protein virus Dengue. Tes ini sangat akurat jika dilakukan pada hari ke-1 hingga hari ke-3 setelah demam pertama kali muncul.
- **Tes Serologi (IgM dan IgG Dengue)**: Pemeriksaan darah untuk mendeteksi antibodi yang dibentuk tubuh untuk melawan virus. Tes ini biasanya efektif dilakukan setelah demam berlangsung selama 5 hari atau lebih.
- **Pemeriksaan Darah Lengkap (CBC)**: Pemantauan berkala terhadap penurunan kadar trombosit dan peningkatan nilai hematokrit (kekentalan darah).

Pengobatan

Hingga saat ini, belum ditemukan obat khusus (antivirus) untuk menyembuhkan DBD. Pengobatan yang diberikan bersifat suportif, bertujuan untuk meredakan gejala dan mempertahankan volume cairan tubuh:

- **Terapi Cairan (Sangat Krusial)**: Pasien diwajibkan mengonsumsi banyak cairan seperti air putih, larutan oralit, cairan elektrolit, atau jus buah untuk mencegah dehidrasi akibat kebocoran pembuluh darah. Jika pasien terus muntah dan tidak bisa minum, cairan harus diberikan melalui **infus** di rumah sakit.
- **Parasetamol**: Obat ini aman digunakan untuk membantu menurunkan demam tinggi dan meredakan nyeri sendi pada pasien DBD.
- **PANTANGAN UTAMA (Hindari Aspirin dan Ibuprofen)**: Pasien DBD **dilarang keras** mengonsumsi obat penurun panas jenis Aspirin, Ibuprofen, maupun Asam Mefenamat. Obat-obatan tersebut memiliki efek samping mengencerkan darah, sehingga dapat memperparah atau memicu perdarahan dalam tubuh yang berakibat fatal.

Pencegahan

Cara paling efektif untuk mencegah penularan DBD adalah dengan memutus siklus hidup nyamuk penular melalui gerakan **3M Plus** secara rutin seminggu sekali:

- **Menguras**: Membersihkan dan menyikat tempat penampungan air seperti bak mandi, ember, dan vas bunga secara berkala.
- **Menutup**: Menutup rapat-rapat semua tempat penyimpanan air agar tidak dijadikan tempat nyamuk untuk bertelur.

==========

- **Mendaur Ulang**: Memanfaatkan kembali atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan (seperti ban bekas atau botol kosong) agar tidak menjadi sarang jentik nyamuk.
- **Aktivitas Plus**: Menggunakan losion anti nyamuk, memasang kelambu di tempat tidur, memelihara ikan pemakan jentik (seperti ikan cupang), serta menggunakan pakaian lengan panjang saat beraktivitas di area yang rawan..

Kapan harus ke dokter

Fase kritis DBD terjadi saat demam mulai turun (biasanya hari ke-3 hingga ke-5). Pasien harus **segera dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD)** terdekat jika menunjukkan tanda-tanda bahaya (*warning signs*) berikut:

- Muntah secara terus-menerus dan tidak bisa menelan makanan atau minuman sama sekali.
- Terjadi perdarahan spontan, seperti mimisan, gusi berdarah tanpa sebab, muntah darah, atau buang air besar berwarna hitam pekat.
- Tubuh terasa lemas ekstrem, tampak gelisah, mengalami sesak napas, atau mengalami penurunan kesadaran.
- Nyeri perut atau kram perut yang sangat hebat.
- Ujung tangan dan kaki terasa dingin, lembap, dan tampak pucat (tanda-tanda tubuh mengalami syok akibat kekurangan cairan).
- Faktor risiko

Risiko seseorang untuk terinfeksi dan mengalami kondisi DBD yang parah akan meningkat disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- **Wilayah Geografis**: Tinggal atau sedang berkunjung ke daerah beriklim tropis dan subtropis (seperti Indonesia) di mana suhu yang hangat dan kelembapan yang tinggi menjadi lingkungan ideal bagi nyamuk Aedes untuk hidup.
- **Lingkungan Kurang Bersih**: Adanya genangan air bersih di sekitar pemukiman (seperti talang air yang mampet, tatakan pot bunga, atau sampah plastik) yang dibiarkan terbuka sehingga menjadi tempat berkembang biak utama bagi nyamuk.
- **Riwayat Infeksi Sebelumnya**: Seseorang yang pernah terkena virus Dengue di masa lalu memiliki risiko yang jauh lebih tinggi untuk mengalami komplikasi DBD yang parah (seperti *Dengue Shock Syndrome*) jika mereka terinfeksi kembali oleh varian virus Dengue yang berbeda.

Referensi medis

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) — Panduan Praktis Klinis Tata Laksana Demam Berdarah Dengue.

World Health Organization (WHO) — *Dengue and Severe Dengue Guidelines for Diagnosis, Treatment, Prevention and Control*.

==========

PENYAKIT : DEMAM TIFOID

==========

Pengertian

Infeksi sistemik akibat bakteri pada saluran cerna.

Penyebab

Bakteri Salmonella typhi.

Gejala

Demam naik di malam hari, lidah kotor, diare atau sembelit.

Diagnosis

Belum tersedia.

Pengobatan

Antibiotik spesifik, istirahat total, diet makanan lunak.

Pencegahan

Cuci tangan sebelum makan, vaksinasi tifoid, makan makanan matang.

Kapan harus ke dokter

Demam tinggi persisten, BAB berdarah, nyeri perut hebat.

Faktor risiko

Sanitasi buruk, konsumsi makanan/minuman tidak higienis.

Referensi medis

CDC, Kemenkes RI

==========

PENYAKIT : GASTRITIS (MAAG)

==========

Pengertian

Peradangan pada lapisan dinding lambung.

Penyebab

Infeksi H. pylori, stres, konsumsi NSAID, alkohol.

Gejala

Nyeri ulu hati, mual, perut kembung, sering bersendawa.

Diagnosis

Belum tersedia.

Pengobatan

Antasida, obat PPI/H2 Blocker.

Pencegahan

Makan teratur porsi kecil, kelola stres, kurangi kafein.

Kapan harus ke dokter

Muntah darah, BAB hitam seperti aspal, nyeri perut tak tertahankan.

Faktor risiko

Telat makan, sering makan pedas/asam, merokok.

Referensi medis

Mayo Clinic, Kemenkes RI

==========

PENYAKIT : DIABETES MELITUS TIPE 2

==========

Pengertian

Diabetes Melitus Tipe 2 (DMT2) adalah penyakit gangguan metabolisme jangka panjang (kronis) yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa atau gula di dalam darah (hiperglikemia). Pada kondisi normal, gula yang kita makan akan diubah menjadi energi dengan bantuan hormon bernama **insulin**. Namun, pada penderita diabetes tipe 2, tubuh tidak dapat menggunakan insulin tersebut secara efektif. Akibatnya, gula menumpuk di dalam aliran darah dan dalam jangka panjang dapat merusak pembuluh darah serta organ-organ penting tubuh lainnya.

Penyebab

Penyebab utama dari Diabetes Melitus Tipe 2 adalah kondisi yang disebut **resistensi insulin**. Pada kondisi ini, sel-sel tubuh (seperti sel otot, lemak, dan hati) mengabaikan signal dari insulin, sehingga mereka menolak untuk menyerap gula dari aliran darah.

Untuk mengatasi penolakan ini, organ **pankreas** dipaksa memproduksi insulin lebih banyak lagi. Seiring berjalannya waktu, sel-sel pembuat insulin di pankreas akan kelelahan, rusak, dan akhirnya tidak mampu lagi memproduksi cukup insulin untuk mengontrol kadar gula darah tubuh

Gejala

Gejala Diabetes Melitus Tipe 2 sering kali berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun, sehingga banyak orang tidak menyadarinya pada tahap awal. Beberapa gejala klasik yang sangat khas (sering disebut gejala 3P) meliputi:

- **Poliuria (Sering Pipis)**: Ginjal berusaha keras membuang kelebihan gula darah melalui urine, menyebabkan penderita menjadi sangat sering buang air kecil, terutama pada malam hari.
- **Polidipsi (Sering Haus)**: Karena tubuh kehilangan banyak cairan akibat sering buang air kecil, penderita akan terus-menerus merasa haus yang luar biasa.
- **Polifagia (Cepat Lapar)**: Karena sel-sel tubuh tidak bisa menyerap gula untuk dijadikan energi, tubuh merasa "kelaparan" sehingga memicu rasa lapar yang konstan meskipun pasien baru saja makan.
- **Penyembuhan Luka yang Lambat**: Kadar gula darah yang tinggi merusak aliran darah dan saraf, membuat luka kecil atau lecet membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sembuh dan mudah terinfeksi.
- **Pandangan Kabur**: Kadar gula darah yang melonjak tinggi dapat menarik cairan dari lensa mata, membuat mata sulit fokus dan pandangan menjadi buram.

==========

Diagnosis

Diagnosis Diabetes Melitus Tipe 2 sudah sangat maju dan tersedia luas di puskesmas, klinik, maupun rumah sakit.

Dokter menegakkan diagnosis diabetes menggunakan pemeriksaan laboratorium darah berikut (berdasarkan panduan PERKENI dan ADA):

- **Tes Gula Darah Puasa (GDP)**: Mengukur kadar gula darah setelah pasien berpuasa (tidak makan) selama minimal 8 jam. Angka ≥ 126 mg/dL menunjukkan diabetes.
- **Tes Gula Darah Sewaktu (GDS)**: Mengukur kadar gula darah kapan saja tanpa perlu berpuasa. Angka ≥ 200 mg/dL yang disertai gejala klasik (sering haus/pipis) sudah cukup untuk mendiagnosis diabetes.
- **Tes Gula Darah 2 Jam Post-Prandial (GD2PP)**: Mengukur kadar gula darah dua jam setelah pasien meminum larutan gula khusus saat tes. Angka ≥ 200 mg/dL menunjukkan diabetes.
- **Tes HbA1c**: Tes darah yang sangat akurat untuk melihat rata-rata kadar gula darah pasien selama 2 hingga 3 bulan terakhir. Angka ≥ 6,5% menunjukkan kondisi diabetes.

Pengobatan

Pengobatan Diabetes Melitus Tipe 2 bersifat jangka panjang dan bertujuan untuk menjaga kadar gula darah sedekat mungkin dengan angka normal guna mencegah komplikasi:

- **Obat Penurun Gula Darah Oral**: Obat pertama yang paling sering diresepkan dokter adalah **Metformin**. Obat ini bekerja dengan cara meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin dan mengurangi produksi gula oleh organ hati. Ada juga jenis obat lain seperti Sulfonilurea yang membantu pankreas memproduksi lebih banyak insulin.
- **Terapi Insulin**: Jika obat-obatan minum sudah tidak mampu mengontrol gula darah (atau jika fungsi pankreas sudah sangat menurun), dokter akan memberikan suntikan hormon insulin buatan secara berkala.

==========

- **Manajemen Pola Makan (Diet Sehat)**: Mengatur jadwal makan, porsi makan, dan jenis makanan. Fokus utama adalah membatasi karbohidrat sederhana (nasi putih berlebih, tepung) dan memperbanyak serat (sayur dan buah indeks glikemik rendah).

Pencegahan

Sebagian besar kasus Diabetes Melitus Tipe 2 dapat dicegah atau ditunda perkembangannya melalui perubahan gaya hidup sehat:

- **Membatasi Konsumsi Gula Harian**: Mengurangi makanan dan minuman manis, camilan tinggi karbohidrat, serta beralih ke pemanis yang lebih sehat.
- **Olahraga Secara Teratur**: Melakukan aktivitas fisik seperti jalan cepat, bersepeda, atau berenang minimal 30 menit sehari (total 150 menit per minggu). Olahraga membantu sel-sel otot membakar gula darah menjadi energi tanpa tergantung penuh pada insulin.
- **Menjaga dan Menurunkan Berat Badan**: Menjaga berat badan agar tetap berada di rentang ideal. Menurunkan berat badan sebanyak 5% hingga 7% saja dari berat badan awal sudah terbukti menurunkan risiko diabetes secara drastis.

Kapan harus ke dokter

Penderita diabetes harus segera dibawa ke rumah sakit atau dokter spesialis jika mengalami kondisi darurat berikut:

- **Luka yang Membusuk (Gangren)**: Luka di kaki atau bagian tubuh lain yang menghitam, berbau busuk, bernanah, atau meluas dengan cepat. Ini adalah tanda kematian jaringan yang butuh penanganan bedah segera agar tidak perlu diamputasi.
- **Penurunan Kesadaran (Koma Diabetes)**: Pasien tampak sangat mengantuk, bingung, meracau, atau pingsan akibat kadar gula darah yang terlalu tinggi ekstrem (Ketoasidosis Diabetik / HHS) atau terlalu rendah ekstrem (Hipoglikemia).
- **Sesak Napas**: Napas terasa berat, cepat, dan dalam yang disertai aroma buah dari mulut (tanda penumpukan asam berbahaya di dalam darah).

Faktor risiko

Ada beberapa faktor yang membuat seseorang memiliki kemungkinan lebih besar terkena penyakit ini:

- **Obesitas dan Overweight**: Memiliki jaringan lemak berlebih, terutama di sekitar perut (obesitas buncit), yang memicu pelepasan zat kimia penyebab resistensi insulin.
- **Gaya Hidup Sedenter**: Jarang bergerak, malas berolahraga, atau terlalu banyak menghabiskan waktu dengan duduk diam setiap harinya.

==========

- **Riwayat Keluarga (Genetik)**: Memiliki orang tua kandung atau saudara kandung yang menderita Diabetes Tipe 2.
- **Faktor Usia**: Risiko meningkat secara drastis pada orang yang berusia di atas 45 tahun, meskipun saat ini kasus pada usia muda juga terus meningkat akibat pola hidup buruk.

Referensi medis

ADA (American Diabetes Association) — *Standards of Care in Diabetes*.

PERKENI (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia) — Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 di Indonesia.

==========

PENYAKIT : ASMA

==========

Pengertian

Peradangan dan penyempitan saluran napas kronis.

Penyebab

Reaksi alergi atau hiperresponsivitas saluran napas.

Gejala

Sesak napas, dada terasa berat, napas berbunyi (mengi), batuk.

Diagnosis

Belum tersedia.

Pengobatan

Inhaler bronkodilator, kortikosteroid.

Pencegahan

Jauhi alergen (pemicu), jaga kebersihan kasur/kamar.

Kapan harus ke dokter

Serangan asma tidak membaik dengan inhaler, bibir kebiruan.

Faktor risiko

Genetik, paparan debu/asap/bulu hewan, udara dingin, stres.

Referensi medis

==========

PENYAKIT : ANEMIA

==========

Pengertian

Kekurangan sel darah merah atau hemoglobin sehat.

Penyebab

Kurang zat besi, vitamin B12, perdarahan masif/menstruasi berat.

Gejala

5L (lemah, letih, lesu, lelah, lalai), pucat, pusing.

Diagnosis

Belum tersedia.

Pengobatan

Suplemen zat besi, vitamin C untuk penyerapan, transfusi darah.

Pencegahan

Konsumsi makanan kaya zat besi (hati, bayam, daging merah).

Kapan harus ke dokter

Jantung berdebar cepat, pucat ekstrem, pingsan.

Faktor risiko

Kurang gizi, kehamilan, penyakit kronis, riwayat cacingan.

Referensi medis

WHO, IDAI

==========

PENYAKIT : CAMPAK

==========

Pengertian

Penyakit virus menular yang menimbulkan ruam merah.

Penyebab

Virus golongan Paramyxovirus.

Gejala

Demam tinggi, ruam merah, mata merah berair, bercak Koplik di mulut.

Diagnosis

Belum tersedia.

Pengobatan

Suplemen Vitamin A, penurun panas, hidrasi.

Pencegahan

Imunisasi rutin MR/MMR.

Kapan harus ke dokter

Anak tampak sangat lemas, sesak napas, kejang.

Faktor risiko

Tidak imunisasi dasar, kekurangan vitamin A.

Referensi medis

WHO, IDAI

==========

PENYAKIT : MALARIA

==========

Pengertian

Penyakit parasit yang menghancurkan sel darah merah.

Penyebab

Parasit Plasmodium (gigitan nyamuk Anopheles).

Gejala

Demam menggigil siklik, keringat dingin, anemia, sakit kepala.

Diagnosis

Belum tersedia.

Pengobatan

Obat Antimalaria (ACT).

Pencegahan

Profilaksis sebelum ke daerah endemis, kelambu, obat nyamuk.

Kapan harus ke dokter

Kencing berwarna sangat gelap, kejang, penurunan kesadaran.

Faktor risiko

Bepergian ke daerah endemis (Papua, dsb) tanpa perlindungan.

Referensi medis

Kemenkes RI, WHO

==========

PENYAKIT : HEPATITIS A

==========

Pengertian

Peradangan organ hati akibat infeksi virus ringan.

Penyebab

Virus Hepatitis A (HAV).

Gejala

Mata/kulit kuning, urine seperti teh pekat, mual, feses pucat.

Diagnosis

Belum tersedia.

Pengobatan

Istirahat total (bed rest), obat pereda mual, diet hati.

Pencegahan

Vaksinasi Hepatitis A, cuci tangan setelah dari toilet, sanitasi air.

Kapan harus ke dokter

Muntah terus-menerus, tidak masuk asupan cairan sama sekali.

Faktor risiko

Sanitasi lingkungan buruk, makan di tempat tidak higienis.

Referensi medis

CDC, Kemenkes RI

==========

PENYAKIT : HEPATITIS B

==========

Pengertian

Infeksi serius pada hati yang dapat menjadi kronis.

Penyebab

Virus Hepatitis B (HBV).

Gejala

Sering tanpa gejala awal; lemas, kuning pada mata, nyeri perut kanan.

Diagnosis

Belum tersedia.

Pengobatan

Obat antivirus, pemantauan fungsi hati (SGOT/SGPT).

Pencegahan

Vaksinasi Hepatitis B, seks aman, sterilisasi alat medis.

Kapan harus ke dokter

Perut membengkak (asites), muntah darah, linglung.

Faktor risiko

Seks tidak aman, berbagi jarum suntik, transfusi darah tidak aman.

Referensi medis

WHO, Kemenkes R

==========

PENYAKIT : MIGRAIN

==========

Pengertian

Sakit kepala berdenyut sedang-hebat, biasanya satu sisi.

Penyebab

Gangguan saraf, perubahan hormonal, pemicu makanan/stres.

Gejala

Nyeri kepala berdenyut, mual, sensitif terhadap cahaya dan suara.

Diagnosis

Belum tersedia.

Pengobatan

Istirahat di ruang gelap, obat pereda nyeri, triptan.

Pencegahan

Hindari faktor pemicu, tidur cukup, kelola stres.

Kapan harus ke dokter

Sakit kepala terhebat yang pernah dirasakan mendadak, disertai kelumpuhan.

Faktor risiko

Stres tinggi, kurang tidur, konsumsi MSG/kafein berlebih, genetik.

Referensi medis

Mayo Clinic, NHS

PENYAKIT : VERTIGO

==========

Pengertian

Sensasi pusing berputar yang mengganggu keseimbangan.

Penyebab

BPPV (kristal telinga dalam lepas), Meniere, infeksi telinga dalam.

Gejala

Pusing seperti berputar, mual, muntah, telinga berdenging.

Diagnosis

Belum tersedia.

Pengobatan

Obat antivertigo (Betahistine), Terapi fisik (Manuver Epley).

Pencegahan

Bangun tidur perlahan, hindari gerakan kepala mendadak.

Kapan harus ke dokter

Pusing disertai bicara pelo, penglihatan ganda, kelemahan anggota gerak.

Faktor risiko

Usia tua, riwayat cedera kepala, infeksi telinga kronis.

Referensi medis

Cleveland Clinic

==========

PENYAKIT : BATU GINJAL

==========

Pengertian

Endapan mineral keras di dalam ginjal.

Penyebab

Kurang cairan, diet tinggi garam/oksalat, asam urat tinggi.

Gejala

Nyeri kolik tajam di punggung bawah menjalar ke depan, kencing merah/berpasir.

Diagnosis

Belum tersedia.

Pengobatan

Minum banyak air untuk batu kecil, terapi ESWL, operasi.

Pencegahan

Minum 2-3 liter air/hari, kurangi bayam/teh/kacang (tinggi oksalat).

Kapan harus ke dokter

Nyeri tidak mereda dengan obat, tidak bisa kencing, mual muntah parah.

Faktor risiko

Riwayat keluarga, obesitas, konsumsi protein hewani tinggi.

Referensi medis

NIDDK, Kemenkes RI

PENYAKIT : STROKE

==========

Pengertian

Gangguan aliran darah otak karena pecah/tersumbatnya pembuluh darah.

Penyebab

Hipertensi tak terkontrol, gumpalan darah.

Gejala

Wajah turun sebelah, bicara pelo, kelemahan satu sisi tubuh tiba-tiba.

Diagnosis

Belum tersedia.

Pengobatan

Penanganan Golden Hour (<4.5 jam) dengan trombolitik, fisioterapi.

Pencegahan

Kontrol tekanan darah, kurangi lemak, olahraga, tidak merokok.

Kapan harus ke dokter

Segera ke IGD jika muncul gejala FAST (Face, Arms, Speech, Time).

Faktor risiko

Usia tua, fibrilasi atrium (jantung tak beraturan), merokok, kolesterol.

Referensi medis

AHA/ASA, Kemenkes RI

==========

PENYAKIT : PNEUMONIA

==========

Pengertian

Infeksi akut jaringan kantung udara paru (paru-paru basah).

Penyebab

Bakteri Pneumococcus, virus influenza/RSV, jamur.

Gejala

Batuk parah berdahak, demam tinggi menggigil, napas cepat/sesak, nyeri dada saat napas.

Diagnosis

Belum tersedia.

Pengobatan

Antibiotik segera, terapi oksigen, cairan infus (rawat inap).

Pencegahan

Vaksin PCV, vaksin Influenza, cuci tangan rutin, jauhi asap rokok.

Kapan harus ke dokter

Bibir kebiruan (sianosis), kebingungan, sesak napas sangat berat.

Faktor risiko

Usia <2 th atau >65 th, perokok, memiliki penyakit kronis paru.

Referensi medis

WHO, PDPI

==========

PENYAKIT : KURAP

==========

Pengertian

Infeksi jamur pada kulit tubuh bagian luar.

Penyebab

Jamur Dermatofita (ular-ularan).

Gejala

Bercak cincin kemerahan berbatas tegas, bagian tengah tampak sembuh, gatal.

Diagnosis

Belum tersedia.

Pengobatan

Salep antijamur topikal (Ketoconazole) 1-2 minggu rutin.

Pencegahan

Jaga kulit tetap kering, ganti pakaian jika berkeringat, jangan berbagi barang pribadi.

Kapan harus ke dokter

Tidak membaik dengan obat bebas selama 2 minggu, menyebar luas.

Faktor risiko

Tinggal di daerah panas lembap, keringat berlebih, berbagi handuk/pakaian.

Referensi medis

CDC, Kemenkes RI

==========

PENYAKIT : PANU

==========

Pengertian

Gangguan pigmentasi kulit akibat infeksi jamur superfisial.

Penyebab

Pertumbuhan berlebih jamur Malassezia.

Gejala

Bercak putih, coklat, atau merah bersisik halus di punggung/dada, gatal saat berkeringat.

Diagnosis

Belum tersedia.

Pengobatan

Sampo anti-ketombe/antijamur dioles ke badan, salep mikonazol.

Pencegahan

Segera mandi setelah aktivitas fisik berat, kenakan pakaian menyerap keringat.

Kapan harus ke dokter

Bercak menutupi area luas di tubuh, kembali berulang meski diobati.

Faktor risiko

Keringat berlebih, kulit berminyak, cuaca panas, imun turun.

Referensi medis

AAD

==========

PENYAKIT : SARIAWAN

==========

Pengertian

Luka kecil menyakitkan di dalam mulut.

Penyebab

Stres, tergigit, kekurangan vitamin C/B12, infeksi jamur, kawat gigi.

Gejala

Lesi putih/kuning dengan tepi merah di pipi dalam/bibir, perih saat makan.

Diagnosis

Belum tersedia.

Pengobatan

Obat kumur antiseptik, gel sariawan (Aloclair/Kenalog), vitamin C.

Pencegahan

Jaga higienitas mulut, sikat gigi lembut, penuhi gizi seimbang.

Kapan harus ke dokter

Sariawan membesar luar biasa, tak kunjung sembuh >2 minggu, demam.

Faktor risiko

Imunitas turun, alergi asam (nanas/sitrus), kurang jaga kebersihan mulut.

Referensi medis

Mayo Clini

==========

PENYAKIT : TETANUS

==========

Pengertian

Penyakit saraf akut akibat toksin bakteri yang memicu kaku otot.

Penyebab

Infeksi bakteri Clostridium tetani lewat luka kotor.

Gejala

Rahang kaku (trismus), kaku otot leher, kejang melengkung ke belakang jika disentuh.

Diagnosis

Belum tersedia.

Pengobatan

Suntik Anti Tetanus Serum (ATS), rawat inap ICU, pelemas otot.

Pencegahan

Vaksin TT lengkap, bersihkan luka segera dengan sabun & air mengalir.

Kapan harus ke dokter

Segera ke IGD jika tertusuk paku kotor atau mulai ada kesulitan membuka mulut.

Faktor risiko

Luka tusuk paku berkarat, luka bakar kotor, persalinan tidak steril (tetanus neonatorum).

Referensi medis

WHO, Kemenkes RI

PENYAKIT : RABIES

==========

Pengertian

Infeksi virus mematikan pada sistem saraf pusat.

Penyebab

Gigitan/cakaran/liur hewan penular rabies (anjing, kucing, monyet).

Gejala

Demam, takut air (hidrofobia), takut cahaya, air liur berlebih, agresif.

Diagnosis

Belum tersedia.

Pengobatan

Cuci luka di air mengalir & sabun 15 menit, beri Vaksin Anti Rabies (VAR).

Pencegahan

Vaksinasi hewan peliharaan, jangan provokasi hewan liar.

Kapan harus ke dokter

Segera pasca-gigitan hewan berisiko tinggi tanpa menunggu gejala muncul.

Faktor risiko

Tinggal di area endemis rabies, kontak hewan liar.

Referensi medis

WHO, Kemenkes RI

==========

PENYAKIT : KERACUNAN MAKANAN

==========

Pengertian

Penyakit sistem pencernaan akibat makanan/minuman terkontaminasi.

Penyebab

Toksin bakteri (Staphylococcus, Salmonella), parasit, virus.

Gejala

Mual, muntah hebat, kram perut mendadak, diare, beberapa jam pasca makan.

Diagnosis

Belum tersedia.

Pengobatan

Karbon aktif, oralit/hidrasi oral intensif, obat anti mual.

Pencegahan

Cuci bersih bahan makanan, masak daging hingga matang sempurna, simpan makanan di kulkas.

Kapan harus ke dokter

Muntah tidak berhenti seharian, pandangan kabur, tanda dehidrasi berat.

Faktor risiko

Makanan kedaluwarsa, pengolahan kurang matang, penyimpanan tidak tepat (suhu ruang lama).

Referensi medis

CDC, FDA

PENYAKIT : CACINGAN

==========

Pengertian

Infeksi parasit cacing di dalam usus manusia.

Penyebab

Telur cacing tertelan (cacing kremi/gelang) atau larva menembus kulit kaki (cacing tambang).

Gejala

Anus gatal malam hari, perut buncit, berat badan sulit naik walau makan banyak, lemas pucat.

Diagnosis

Belum tersedia.

Pengobatan

Obat cacing (Albendazole/Mebendazole) diulang tiap 6 bulan untuk keluarga.

Pencegahan

Selalu pakai alas kaki, potong kuku anak, cuci tangan sebelum makan.

Kapan harus ke dokter

Keluar cacing utuh lewat mulut/hidung/anus, anak anemia berat pucat pasi.

Faktor risiko

Tidak pakai alas kaki di tanah, cuci tangan tak pakai sabun, lingkungan kumuh.

Referensi medis

WHO, IDAI